

Évaluation ictère

Pr. ALOULOU Hajer

Objectif 3

Décrire le métabolisme de la bilirubine

QCM

Les particularités du métabolisme de la bilirubine chez l'enfant sont:

A- une liaison albumine – bilirubine forte

B- une augmentation du cycle entéro-hépatique de la bilirubine

C- une production faible de la bilirubine lors des premiers jours de vie

D- une diminution de l'activité de la glucuronyltransférase

E- un système d'épuration transitoirement insuffisant

QCM

Les particularités du métabolisme de la bilirubine chez l'enfant sont:

A- une liaison albumine – bilirubine forte

B- une augmentation du cycle entéro-hépatique de la bilirubine

C- une production faible de la bilirubine lors des premiers jours de vie

D- une diminution de l'activité de la glucuronyltransférase

E- un système d'épuration transitoirement insuffisant

Objectif 4

- Expliquer en fonction de l'âge les mécanismes physiopathologiques des ictères à bilirubine conjuguée et des ictères à bilirubine non conjuguée.

QCM

Un ictère cholestatique à GGT normale peut être secondaire à:

A- une anomalie des voies biliaires extrahépatiques

B- un défaut de synthèse des acides biliaires

C- un défaut d'excrétion des acides biliaires

D- une paucité ductulaire

E- une anomalie de transport de la bilirubine au niveau des canalicules biliaires

QCM

Un ictère cholestatique à GGT normale peut être secondaire à:

A- une anomalie des voies biliaires extrahépatiques

B- un défaut de synthèse des acides biliaires

C- un défaut d'excrétion des acides biliaires

D- une paucité ductulaire

E- une anomalie de transport de la bilirubine au niveau des canalicules biliaires

QCM

La cholestase intrahépatique de l'enfant:

A- est une cholestase à GGT normale

B- est associée à une décoloration intermittente des selles

C- est secondaire à une altération du système de transport au niveau de l'hépatocyte

D- peut être secondaire à une obstruction des voies biliaires intrahépatique

E- peut être secondaire à une paucité ductulaire des voies hépatiques

QCM

La cholestase intrahépatique de l'enfant:

A- est une cholestase à GGT normale

B- est associée à une décoloration intermittente des selles

C- est secondaire à une altération du système de transport au niveau de l'hépatocyte

D- peut être secondaire à une obstruction des voies biliaires intrahépatique

E- peut être secondaire à une paucité ductulaire des voies hépatiques

Objectif 5

Distinguer à partir des données de l'anamnèse, de l'examen physique et de la biologie un ictère à bilirubine conjugué d'un ictère à bilirubine non conjugué

QCM:

En faveur d'un ictère hémolytique:

A- une consanguinité parentale

B- une hépatomégalie

C- une splénomégalie

D- une pâleur cutanéomuqueuse

E- des selles décolorées

QCM:

En faveur d'un ictère hémolytique:

A- une consanguinité parentale

B- une hépatomégalie

C- une splénomégalie

D- une pâleur cutanéomuqueuse

E- des selles décolorées

QCM

En faveur d'un ictère cholestatique chez l'enfant:

A- une coloration jaune-orangée des téguments

B- une décoloration partielle des selles

C- un prurit

D- des urines foncées

E- une pâleur cutanéomuqueuse

QCM

En faveur d'un ictère cholestatique chez l'enfant:

A- une coloration jaune-orangée des téguments

B- une décoloration partielle des selles

C- un prurit

D- des urines foncées

E- une pâleur cutanéomuqueuse

QCM

La fonction hépato-cellulaire est étudiée par:

- A- le dosage des protides totaux
- B- le dosage de l'albumine
- C- le dosage des PAL
- D- le taux de prothrombine
- E- le taux des GGT

QCM

La fonction hépato-cellulaire est étudiée par:

A- le dosage des protides totaux

B- le dosage de l'albumine

C- le dosage des PAL

D- le taux de prothrombine

E- le taux des GGT

QCM

L'ictère à Bilirubine non conjugué:

A- est plus fréquent en période néonatale

B- est d'origine héréditaire dans la plupart des cas

C- est secondaire à une hémolyse constitutionnelle dans la plupart des cas

D- peut être en rapport avec une hépatite virale

E- expose au risque d'ictère nucléaire

QCM

L'ictère à Bilirubine non conjugué:

A- est plus fréquent en période néonatale

B- est d'origine héréditaire dans la plupart des cas

C- est secondaire à une hémolyse constitutionnelle dans la plupart des cas

D- peut être en rapport avec une hépatite virale

E- expose au risque d'ictère nucléaire

QCM

Les examens complémentaires à visée étiologiques en cas d'ictère cholestatique comportent:

- A- l'échographie abdominale
- B- le taux des GGT
- C- la sérologie des embryofœtopathies
- D- l'examen ophtalmologique
- E- le test de Coombs direct

QCM

Les examens complémentaires à visée étiologiques en cas d'ictère cholestatique comportent:

- A- l'échographie abdominale
- B- le taux des GGT
- C- la sérologie des embryofœtopathies
- D- l'examen ophtalmologique
- E- le test de Coombs direct

QCM

Les examens complémentaires à visée étiologique en cas d'ictère à BNC à la période néonatale comportent:

- A- la RAI chez la mère
- B- le test de Coombs direct
- C- l'électrophorèse de l'hémoglobine
- D- l'échographie abdominale
- E- la sérologie de l'hépatite B

QCM

Les examens complémentaires à visée étiologique en cas d'ictère à BNC à la période néonatale comportent:

A- la RAI chez la mère

B- le test de Coombs direct

C- l'électrophorèse de l'hémoglobine

D- l'échographie abdominale

E- la sérologie de l'hépatite B

QCM

L'ictère simple:

- A- Est un ictère à BNC
- B- Est plus fréquent chez le nouveau-né prématuré
- C- Expose au risque d'ictère nucléaire
- D- Apparaît après les premières 24heures de vie
- E- S'associe à des urines foncées

QCM

L'ictère simple:

A- Est un ictère à BNC

B- Est plus fréquent chez le nouveau-né prématuré

C- Expose au risque d'ictère nucléaire

D- Apparaît après les premières 24 heures de vie

E- S'associe à des urines foncées

QCM

L'ictère simple:

A- est aggravé par la prématurité

B- disparaît en 8 à 10 jours

C- Touche la totalité des nouveau-nés

D- est associé à une anémie régénérative

E- est secondaire à la résorption d'hématome

QCM

L'ictère simple:

A- est aggravée par la prématurité

B- disparaît en 8 à 10 jours

C- Touche la totalité des nouveau-nés

D- est associé à une anémie régénérative

E- est secondaire à la résorption d'hématome

QCM

L'ictère au lait de mère

- A- apparait dès les premières 24 heures de vie
- B- est isolé
- C- est secondaire à une inhibition de la glucuroconjugaison
- D- touche 20 à 30% des nouveau-né allaités au sein
- E- justifie l'arrêt de l'allaitement maternel

QCM

L'ictère au lait de mère

A- apparait dès les premières 24 heures de vie

B- est isolé

C- est secondaire à une inhibition de la glucuroconjugaison

D- touche 20 à 30% des nouveau-né allaités au sein

E- justifie l'arrêt de l'allaitement maternel

QCM: l'ictère par incompatibilité dans le système ABO :

A- survient dès la première grossesse

B- le test de Coombs direct peut être négatif

C- la RAI chez la mère est souvent négative

D- peut apparaître dès les premières 24 heures

E- peut évoluer vers l'ictère nucléaire

QCM: l'ictère par incompatibilité dans le système ABO :

A- survient dès la première grossesse

B- le test de Coombs direct peut être négatif

C- la RAI chez la mère est souvent négative

D- peut apparaître dès les premières 24 heures

E- peut évoluer vers l'ictère nucléaire

QCM

Le syndrome de Crigler Najjar de type 1:

A- est responsable d'un ictère à BNC

B- expose au risque d'ictère nucléaire

C- est une maladie héréditaire

D- est associé à une hépatomégalie

E- est secondaire à un déficit total de la glucuroconjugaison

QCM

Le syndrome de Crigler Najjar de type 1:

A- est responsable d'un ictère à BNC

B- expose au risque d'ictère nucléaire

C- est une maladie héréditaire

D- est associé à une hépatomégalie

E- est secondaire à un déficit total de la glucuroconjugaison

Cas clinique QCM

Nouveau-né de sexe féminin est admise pour ictère apparu à H7 de vie. Elle est issue d'une première grossesse menée à terme, anamnèse infectieuse (-), la mère est de GS O+, le bébé B+. L'examen trouve un poids à 3500gr, pâleur cutanéomuqueux, pointe de rate, pas d'hépatomégalie. La biologie a montré BT/BC: 250/5 μ mol/l, NFS: GB 18900 Hb: 10.1gr/dl plaquettes: 230000, CRP(-). Le diagnostic d'ictère hémolytique a été retenu.

QCM1: les signes cliniques en faveur de l'hémolyse sont:

- A- des urines claires
- B- une splénomégalie
- C- début avant les premières 24 heures
- D- une consanguinité parentale
- E- une pâleur cutanée

Cas clinique QCM

Nouveau-né de sexe féminin est admise pour ictère apparu à H7 de vie. Elle est issue d'une première grossesse menée à terme, anamnèse infectieuse (-), la mère est de GS O+, le bébé B+. L'examen trouve un poids à 3500gr, pâleur cutanéomuqueux, pointe de rate, pas d'hépatomégalie. La biologie a montré BT/BC: 250/5 μ mol/l, NFS: GB 18900 Hb: 10.1fr/dl plaquettes: 230000, CRP(-). Le diagnostic d'ictère hémolytique a été retenu.

QCM1: les signes cliniques en faveur de l'hémolyse sont:

A- des urines claires

B- une splénomégalie

C- début avant les premières 24 heures

D- une consanguinité parentale

E- une pâleur cutanée

QCM

Les examens complémentaires à visée étiologiques comportent:

A- électrophorèse de l'Hb

B- test de Coombs direct

C- recherche d'hémolysine antiA chez la mère

D- échographie abdominale

E- sérologie des embryofœtopathies

QCM

Les examens complémentaires à visée étiologiques comportent:

A- électrophorèse de l'Hb

B- test de Coombs direct

C- recherche d'hémolysine antiA chez la mère

D- échographie abdominale

E- sérologie des embryofœtopathies

QCM3:

Les complications auxquelles est exposés ce nouveau-né sont:

- A- Ictère nucléaire
- B- Cirrhose de foie
- C- Etat de choc
- D- Retard de croissance
- E- hypertension portale

QCM3:

Les complications auxquelles est exposés ce nouveau-né sont:

A- Ictère nucléaire

B- Cirrhose de foie

C- Etat de choc

D- Retard de croissance

E- hypertension portale

Cas clinique QCM2

Un nourrisson âgé de 20 jours issu d'une grossesse normalement déroulée consulte pour ictère constaté à J5 de vie, devant la persistance de l'ictère la mère a consulté

L'examen a montré: Poids: 4500gr, ictère cutanéomuqueux, HMG, SMG à 2 cm du rebord costal, les urines sont foncées, les selles sont décolorées, le bilan biologique a montré : BT/BC: 230/120 μ mol/l, GGT: 350UI/l, PAL: 550UI/l, ASAT/ALAT: 90/110UI/l, TP:65%

QCM: En faveur de ce diagnostic d'un ictère cholestatique:

- A- une pâleur
- B- une décoloration des selles
- C- des urines foncées
- D- l'hépatosplénomégalie
- E- le début au cours de la première semaine de vie

Cas clinique QCM2

Un nourrisson âgé de 20 jours issu d'une grossesse normalement déroulée consulte pour ictère constaté à J5 de vie, devant la persistance de l'ictère la mère a consulté

L'examen a montré: Poids: 4500gr, ictère cutanéomuqueux, HMG, SMG à 2 cm du rebord costal, les urines sont foncées, les selles sont décolorées, le bilan biologique a montré : BT/BC: 230/120 μ mol/l, GGT: 350UI/l, PAL: 550UI/l, ASAT/ALAT: 90/110UI/l, TP:65%

QCM: En faveur de ce diagnostic d'un ictère cholestatique:

A- une pâleur

B- une décoloration des selles

C- des urines foncées

D- l'hépatosplénomégalie

E- le début au cours de la première semaine de vie

Cas clinique QCM2

QCM2: les examens complémentaires à visé étiologiques comportent:

A- une échographie abdominale

B- un examen ophtalmologique

C- une sérologie de l'hépatite B

D- une sérologie des embryofœtopathies

E- un test de Coombs direct

Cas clinique QCM2

QCM2: les examens complémentaires à visé étiologiques comportent:

A- une échographie abdominale

B- un examen ophtalmologique

C- une sérologie de l'hépatite B

D- une sérologie des embryofetopathies

E- un test de Coombs direct

Cas clinique QCM2

QCM3: la conduite urgente chez ce nouveau-né est:

- A- Une biopsie hépatique
- B- Administration de 10 mg de vitamine K en IM
- C- La prescription de l'acide ursodesoxycholique
- D- Une ampoule de vitamine D3 en IM
- E- Une échographie cardiaque

Cas clinique QCM2

QCM3: la conduite urgente chez ce nouveau-né est:

A- Une biopsie hépatique

B- Administration de 10 mg de vitamine K en IM

C- La prescription de l'acide ursodesoxycholique

D- Une ampoule de vitamine D3 en IM

E- Une échographie cardiaque

Cas clinique QCM2

QCM4: les étiologies de cette cholestase peuvent comporter:

A- une cholestase fibrogène familiale type 1

B- une cholestase fibrogène familiale type 2

C- une atrésie des voies biliaires

D- cholangite sclérosante à début néonatale

E- déficit de synthèse des acides biliaires

Cas clinique QCM2

QCM4: les étiologies de cette cholestase peuvent comporter:

A- une cholestase fibrogène familiale type 1

B- une cholestase fibrogène familiale type 2

C- une atrésie des voies biliaires

D- cholangite sclérosante à début néonatale

E- déficit de synthèse des acides biliaires

QCM

QCM: L'atrésie des voies biliaires:

A- est responsable d'une cholestase à GGT élevée

B- représente 25 à 40% des cholestase

C- est responsable d'une décoloration intermittente des selles

D- est associée à un retard de croissance intra-utérin

E- est héréditaire

QCM

QCM: L'atrésie des voies biliaires:

A- est responsable d'une cholestase à GGT élevée

B- représente 25 à 40% des cholestase

C- est responsable d'une décoloration intermittente des selles

D- est associée à un retard de croissance intra-utérin

E- est héréditaire

QCM: les éléments échographiques en faveur du diagnostic de l'atrésie des voies biliaires:

A- une dilatation kystique du cholédoque

B- une polysplénie

C- une dilatation des voies biliaires

D- une absence de la vésicule biliaire

E- une hépatomégalie

QCM: les éléments échographiques en faveur du diagnostic de l'atrésie des voies biliaires:

A- une dilatation kystique du cholédoque

B- une polysplénie

C- une dilatation des voies biliaires

D- une absence de la vésicule biliaire

E- une hépatomégalie

QCM: la dérivation bilio-digestive de kasai:

- A- Doit être faite avant l'âge de 30 jours
- B- Est le traitement chirurgical de l'atrésie des voies biliaires
- C- Permet de guérir définitivement l'AVB
- D- peut être compliquée de cholangite infectieuse
- E- Permet de retarder l'âge de la transplantation hépatique

QCM: la dérivation bilio-digestive de kasai:

- A- Doit être faite avant l'âge de 30 jours
- B- Est le traitement chirurgical de l'atrésie des voies biliaires
- C- Permet de guérir définitivement l'AVB
- D- peut être compliquée de cholangite infectieuse
- E- Permet de retarder l'âge de la transplantation hépatique

QCM: devant un tableau de cholestase complète du nouveau-né, les étiologies comportent:

A- La mucoviscidose

B- Le syndrome d'Alagille

C- L'atrésie des voies biliaires

D- La cholestase fibrogène familiale de type 1

E- Le déficit de synthèse des acides biliaires

QCM: devant un tableau de cholestase complète du nouveau-né, les étiologies comportent:

A- La mucoviscidose

B- Le syndrome d'Alagille

C- L'atrésie des voies biliaires

D- La cholestase fibrogène familiale de type 1

E- Le déficit de synthèse des acides biliaires

QCM: les cholestases fibrogènes familiales:

- A- sont toujours des cholestases à GGT normales
- B- représentent 10% des cholestases néonatales
- C- sont des pathologies héréditaires
- D- sont responsables d'un tableau de cholestase complète
- E- sont les plus prurigineuses parmi les étiologies des cholestases

QCM: les cholestases fibrogènes familiales:

A- sont toujours des cholestases à GGT normales

B- représentent 10% des cholestases néonatales

C- sont des pathologies héréditaires

D- sont responsables d'un tableau de cholestase complète

E- sont les plus prurigineuses parmi les étiologies des cholestases

QCM: la cholestase fibrogène familiale de type 1:

A- est autosomiques récessive

B- est associée à une décoloration intermittente des selles

C- est associée à un taux normal des acides biliaires

D- est une cholestase à GGT normale

E- est de début néonatal

QCM: la cholestase fibrogène familiale de type 1:

A- est autosomiques récessive

B- est associée à une décoloration intermittente des selles

C- est associée à un taux normal des acides biliaires

D- est une cholestase à GGT normale

E- est de début néonatal

QCM: les arguments clinico-biologiques en faveur d'un syndrome d'Alagille comportent:

- A- une décoloration permanente des selles
- B- une dysmorphie faciale
- C- une paucité ductulaire
- D- un taux de GGT normal
- E- une malformation vertébrale en aile de papillon

QCM: les arguments clinico-biologiques en faveur d'un syndrome d'Alagille comportent:

A- une décoloration permanente des selles

B- une dysmorphie faciale

C- une paucité ductulaire

D- un taux de GGT normal

E- une malformation vertébrale en aile de papillon

QCM: les cholestases de l'enfant de révélation tardive comportent:

A- l'hépatite virale A

B- l'hépatite virale à CMV

C- la maladie de wilson

D- l'atrésie des voies biliaires

E- la lithiase biliaire

QCM: les cholestases de l'enfant de révélation tardive comportent:

A- l'hépatite virale A

B- l'hépatite virale à CMV

C- la maladie de wilson

D- l'atrésie des voies biliaires

E- la lithiase biliaire